認定結果(テスト用設定)

テスト用架空事例

要介護度	要介護4
認定日	令和8年10月21日(テスト用)
認定の有効期間	令和8年11月1日～令和9年10月31日(12か月)(テスト用)

認 定 調 査 票 (概 況 調 査)

Ⅰ 調査実施者(記入者)

実施日時	令和8年9月30日 (テスト用)
実施場所	自宅
記入者氏名・所属	＊＊＊＊(テスト用)

Ⅱ 調査対象者

過去の認定	更新申請(前回:要介護3)		
対象者氏名	藤田 ミツ (ふじた みつ)	性別	女
生年月日	昭和11年(1936年)2月28日	年齢	90歳
現住所	○○県○○市＊＊＊＊(テスト用)		
家族等連絡先	＊＊＊＊(テスト用)		

Ⅲ 現在受けているサービスの状況

介護給付 通所介護(週2回・入浴あり)、短期入所生活介護(月10日)、訪問介護(身体介護・週3回・おむつ交換)、福祉用具貸与(特殊寝台・特殊寝台付属品・車いす・床ずれ防止用具)。

Ⅳ 置かれている環境等(調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等)

家族状況	長女夫婦(長女62歳・夫64歳)と同居。主な介護者は長女。長女の夫は日中仕事。
居住環境	築30年の木造2階建て持ち家。本人の部屋は1階の洋室(介護ベッド)。
使用している機器等	特殊寝台、車いす、床ずれ防止用具(エアマット)、紙おむつ。
生活歴	呉服店に勤め、着物の着付けを長く教えていた。
本人・家族の主訴	本人:(意向ははっきりしないが)「家がいい」と話す。 長女:「夜中に何度も起こされて、私が倒れそう。ショートステイを増やしたい。」

認定調査票(基本調査)

テスト用架空事例

該当する選択肢を〇で囲んでいます。

第1群 身体機能・起居動作	
1-1 麻痺等の有無 (複数選択可)	ない　左上肢　(右上肢)　左下肢　(右下肢)　その他(四肢の欠損)
1-2 拘縮の有無 (複数選択可)	ない　肩関節　股関節　(膝関節)　その他(四肢の欠損)
1-3 寝返り	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-4 起き上がり	つかまらないでできる　何かにつかまればできる　(できない)
1-5 座位保持	できる　(自分の手で支えればできる)　支えてもらえればできる　できない
1-6 両足での立位保持	支えなしでできる　何か支えがあればできる　(できない)
1-7 歩行	つかまらないでできる　何かにつかまればできる　(できない)
1-8 立ち上がり	つかまらないでできる　何かにつかまればできる　(できない)
1-9 片足での立位	支えなしでできる　何か支えがあればできる　(できない)
1-10 洗身	介助されていない　一部介助　(全介助)　行っていない
1-11 つめ切り	介助されていない　一部介助　(全介助)
1-12 視力	(普通(日常生活に支障がない))　約1m離れた視力確認表の図が見える 目の前に置いた視力確認表の図が見える　ほとんど見えない 見えているのか判断不能
1-13 聴力	(普通)　普通の声がやっと聞き取れる　かなり大きな声なら何とか聞き取れる ほとんど聞えない　聞えているのか判断不能
第2群 生活機能	
2-1 移乗	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
2-2 移動	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
2-3 えん下	できる　(見守り等)　できない
2-4 食事摂取	介助されていない　見守り等　(一部介助)　全介助
2-5 排尿	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
2-6 排便	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
2-7 口腔清潔	介助されていない　一部介助　(全介助)
2-8 洗顔	介助されていない　一部介助　(全介助)
2-9 整髪	介助されていない　一部介助　(全介助)
2-10 上衣の着脱	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
2-11 ズボン等の着脱	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
2-12 外出頻度	週1回以上　(月1回以上)　月1回未満
第3群 認知機能	
3-1 意思の伝達	調査対象者が意思を他者に伝達できる　(ときどき伝達できる) ほとんど伝達できない　できない
3-2 毎日の日課を理解	できる　(できない)
3-3 生年月日や年齢を言う	できる　(できない)
3-4 短期記憶	できる　(できない)
3-5 自分の名前を言う	(できる)　できない
3-6 今の季節を理解する	できる　(できない)
3-7 場所の理解	できる　(できない)
3-8 徘徊	(ない)　ときどきある　ある

3-9 外出すると戻れない	(ない)　ときどきある　ある　テスト用架空事例
第4群 精神・行動障害	
4-1 物を盗られたなどと被害的になる	(ない)　ときどきある　ある
4-2 作話	(ない)　ときどきある　ある
4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる	ない　(ときどきある)　ある
4-4 昼夜の逆転がある	ない　ときどきある　(ある)
4-5 しつこく同じ話をする	(ない)　ときどきある　ある
4-6 大声をだす	ない　ときどきある　(ある)
4-7 介護に抵抗する	ない　(ときどきある)　ある
4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない	ない　(ときどきある)　ある
4-9 一人で外に出たがり目が離せない	(ない)　ときどきある　ある
4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる	(ない)　ときどきある　ある
4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする	(ない)　ときどきある　ある
4-12 ひどい物忘れ	ない　ときどきある　(ある)
4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする	(ない)　ときどきある　ある
4-14 自分勝手に行動する	(ない)　ときどきある　ある
4-15 話がまとまらず、会話にならない	ない　(ときどきある)　ある
第5群 社会生活への適応	
5-1 薬の内服	介助されていない　一部介助　(全介助)
5-2 金銭の管理	介助されていない　一部介助　(全介助)
5-3 日常の意思決定	できる(特別な場合でもできる)　特別な場合を除いてできる　(日常的に困難) できない
5-4 集団への不適応	(ない)　ときどきある　ある
5-5 買い物	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
5-6 簡単な調理	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)

その他 過去14日間に受けた特別な医療

□点滴の管理　□中心静脈栄養　□透析　□ストーマ(人工肛門)の処置　□酸素療法　□レスピレーター(人工呼吸器)
□気管切開の処置　□疼痛の看護　□経管栄養　□モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)　□じょくそうの処置
□カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)	自立　J1　J2　A1　A2　B1　(B2)　C1　C2
認知症高齢者の日常生活自立度	自立　Ⅰ　Ⅱa　Ⅱb　Ⅲa　(Ⅲb)　Ⅳ　M

認定調査票（特記事項）

テスト用架空事例

第1群 身体機能・起居動作	1-1 右上下肢に麻痺がある(令和8年4月の脳梗塞の再発後)。1-2 右膝が伸びきらない。 1-3 ベッド柵につかまれば横を向ける。1-4 起き上がりは長女が介助する。 1-5 ベッドの端に座ると、手で支えて座っていられる。 1-6〜1-8 立つことはできない。
第2群 生活機能	2-1 ベッドから車いすへは、長女が抱えて移乗する。2-2 移動は車いすで介助。 2-3・2-4 刻み食をスプーンで自分で口に運ぶが、途中で手が止まるため介助する。むせることがある。 2-5・2-6 おむつを使用。夜間も2〜3回交換する。 2-12 通所介護と短期入所に、車いすで出かけている。
第3群 認知機能	3-1 簡単な返事はできるが、要件を伝えることは難しい。3-5 名前は答えられた。
第4群 精神・行動障害	4-4 昼間はうとうとし、夜中に目を覚ます。4-6 夜中に大きな声で長女を呼ぶことがほぼ毎晩ある。 4-8 夕方から夜に「家に帰る」と言って落ち着かなくなる。 夜間の対応で、長女は毎晩2〜3回起きている。
第5群 社会生活への適応	5-1〜5-6 すべて長女が行っている。
特別な医療	該当なし。

主 治 医 意 見 書

テスト用架空事例

申請者	藤田 ミツ (女・90歳) 医療機関名・医師氏名:＊＊＊＊(テスト用)

1. 傷病に関する意見

(1)診断名	発症年月日
1. 血管性認知症	約4年前
2. 脳梗塞(再発)後遺症(右片麻痺)	令和8年4月
3. 高血圧症	約30年前
(2)症状としての安定性	安定
(3)経過及び治療内容	令和4年に脳梗塞を発症し、その後血管性認知症と診断。令和8年4月に脳梗塞が再発し、右片麻痺が加わった。退院後は症状に大きな変化はない。夜間に覚醒し大声を出すことが多い。 投薬:抗血小板薬、降圧薬、抑肝散。

2. 特別な医療(過去14日間以内に受けた医療)

なし

3. 心身の状態に関する意見

(1)日常生活の自立度等	障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度):B2 認知症高齢者の日常生活自立度:IIIb
(2)認知症の中核症状	短期記憶:問題あり/日常の意思決定:判断できない/意思の伝達:具体的要求に限られる
(3)認知症の行動・心理症状	昼夜逆転、大声、夜間の帰宅願望
(4)その他の精神・神経症状	なし
(5)身体の状態	利き腕:右/身長142cm・体重38kg/麻痺:右上肢・右下肢(中等度)/関節の拘縮:右膝/褥瘡なし(仙骨部の発赤に注意)

4. 生活機能とサービスに関する意見

(1)移動	屋外歩行:していない/車いす:主に他人が操作/歩行補助具:使用していない
(2)栄養・食生活	食事行為:一部介助/栄養状態:やや不良/留意点:刻み食、とろみ、誤嚥に注意
(3)現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針	誤嚥性肺炎、褥瘡、脳梗塞の再々発、介護者の疲労 → 食事形態の工夫、体位変換、短期入所による介護者の休息
(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し	期待できない
(5)医学的管理の必要性	特になし
(6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項	嚥下:誤嚥に注意/皮膚:仙骨部の観察
(7)感染症の有無	なし

5. 特記すべき事項

夜間の不穏と大声が続き、主介護者の長女の睡眠が確保できていない。短期入所の利用を含めた介護者支援が必要。